BONUS 2

Uzman Hocanın En Sık Düzelttiği 50 Rapor Hatası

Raporların geri dönmesine neden olan 50 hata; her biri «Yazılan → Doğrusu → Neden» düzeninde. Hocanızın kırmızı kalemiyle karşılaşmadan önce kendi raporunuzu düzeltin.

İçindekiler

Bu liste nasıl kullanılır

Teknik ve karşılaştırma — 6 hata

Terminoloji — 7 hata

Lokalizasyon, taraf ve ölçüm — 8 hata

Bulgular — 9 hata

Sonuç — 8 hata

Öneri — 4 hata

Acil bulgu ve bildirim — 4 hata

Biçim ve imza öncesi — 4 hata

Sonraki adım

BAŞLARKEN

Bu liste nasıl kullanılır

Hatalar 4 adımlı metoda göre gruplanmıştır: HAZIRLA, TARA, TANIMLA, ÖZETLE.

> *Rapor hatalarının çoğu bilgi eksikliğinden değil, alışkanlıktan doğar. Alışkanlık ise bir kez fark edilince düzelir.*

METOTTAKİ ADIM	İLGİLİ HATA GRUPLARI
HAZIRLA	Teknik ve karşılaştırma
TARA	Bulgular (atlama ve önemli negatifler)
TANIMLA	Terminoloji · Lokalizasyon, taraf ve ölçüm · Bulgular
ÖZETLE	Sonuç · Öneri · Acil bulgu ve bildirim · Biçim ve imza öncesi

1. **Bir hafta boyunca her gün bir grup okuyun.** Sekiz grup, sekiz gün.
2. **Hocanızın düzelttiği her raporu bu listeyle eşleştirin.** Aynı hata iki kez tekrarlıyorsa onu kontrol listenize ekleyin.
3. **İmzadan önce Tek Sayfa Rapor Kontrol Listesi'ni uygulayın.** Listedeki maddeler bu 50 hatanın özetidir.

Kurum pratiği

Bölümünüzün rapor formatı veya terim tercihleri buradaki örneklerden farklıysa bölümünüzün kuralı geçerlidir. Asıl amaç ilkeyi yakalamaktır: açık, ölçülü, karşılaştırmalı ve soruya yanıt veren rapor.

GRUP 1

Teknik ve karşılaştırma

6 hata · Yazılan → Doğrusu → Neden

NO	YAZILAN	DOĞRUSU	NEDEN
01	Teknik alanı boş bırakılmış.	«Kontrastsız beyin BT; aksiyel kesitler beyin ve kemik penceresinde değerlendirilmiştir.»	*Okuyan, hangi tetkikin ve hangi koşullarda değerlendirildiğini bilmeden bulguların gücünü tartamaz.*
02	«IV kontrastlı abdomen BT.»	«IV kontrastlı abdomen-pelvis BT, portal venöz faz.»	*Faz, bir bulgunun görülüp görülmeyeceğini belirler; arteriyel faz bilgisi olmadan aktif kanama yorumu yapılamaz.*
03	Teknik yetersizlik yazılmamış (hareket artefaktı, yetersiz inspirasyon).	«Hareket artefaktı nedeniyle posterior fossa değerlendirmesi sınırlıdır.»	*Sınırlılık yazılmazsa «bulgu yok» cümlesi gerçekte olduğundan daha güvenilir okunur.*
04	«Önceki tetkikle karşılaştırıldı.»	«**[Tarih]** tarihli toraks BT ile karşılaştırılmıştır.»	*Tarih ve modalite olmadan hangi tetkikle kıyaslandığı doğrulanamaz.*
05	Önceki tetkik varken karşılaştırma yapılmamış.	«Önceki tetkike göre nodül boyutu **[.. mm]**'den **[.. mm]**'ye artmıştır.»	*Takip tetkikinin asıl sorusu çoğu zaman değişimdir; karşılaştırma yoksa rapor soruya yanıt vermez.*
06	«Karşılaştırma: yok.»	«Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.»	*«Yok» belirsizdir: sistemde mi yok, bakılmadı mı? Açık cümle bu soruyu ortadan kaldırır.*

GRUP 2

Terminoloji

7 hata · Yazılan → Doğrusu → Neden

NO	YAZILAN	DOĞRUSU	NEDEN
07	BT'de «hiperintens lezyon».	BT'de «hiperdens lezyon».	*BT'de dansite, MR'da sinyal, USG'de ekojenite kullanılır; yanlış terim modaliteyi bilmediğiniz izlenimini verir.*
08	USG'de «hipodens kitle».	USG'de «hipoekoik kitle».	*Ekojenite USG'ye özgü terimdir.*
09	Kist için «hipoekoik».	Basit kist için «anekoik».	*Anekoik ile hipoekoik farklı içerik anlamına gelir; basit kist tanısı bu farka dayanır.*
10	«Tümör izlendi.»	«[.. mm] kitle lezyonu izlendi.»	*Tümör histolojik bir tanıdır; görüntüleme bulgusu kitle veya lezyon olarak tanımlanır.*
11	«İnfiltrasyon» (grafide her opasite için).	«Konsolidasyon», «buzlu cam», «retiküler opasite» gibi tanımlayıcı terim.	*«İnfiltrasyon» belirsizdir ve farklı hekimler için farklı anlamlar taşır.*
12	«Kitle etkisi var.»	«Sulkal silinme, ipsilateral ventrikülde basılanma ve [.. mm] orta hat şifti.»	*Kitle etkisinin derecesi ölçü ve bulguyla verilmelidir; klinik karar buna göre değişir.*
13	«Normal sınırlarda» (her şey için).	İlgili organları kısaca tek tek yazın: «Karaciğer, dalak ve böbrekler doğal.»	*Neyin değerlendirildiği belirsiz kalır; okuyan atlanan organı fark edemez.*

GRUP 3

Lokalizasyon, taraf ve ölçüm

8 hata · Yazılan → Doğrusu → Neden

NO	YAZILAN	DOĞRUSU	NEDEN
14	Taraf yazılmamış: «Plevral efüzyon.»	«Sağ plevral efüzyon.»	*Taraf eksikliği torasentez veya cerrahi gibi girişimlerde ciddi hataya yol açabilir.*
15	Şablondan kalan yanlış taraf.	Taraf, görüntü üzerindeki işaret ve istem ile ikinci kez kontrol edilir.	*Kopyala-yapıştır hatalarının en tehlikelisidir; Bulgular ve Sonuç'ta taraf aynı olmalıdır.*
16	«Sol akciğerde lezyon.»	«Sol alt lob superior segmentte lezyon.»	*Lob ve segment bilgisi hem takipte hem bronkoskopi veya biyopsi planlamasında gereklidir.*
17	«Büyük kitle», «küçük nodül».	«**[.. x .. mm]** kitle», «**[.. mm]** nodül».	*Sıfatlar ölçü değildir; takipte değişim ancak sayıyla değerlendirilebilir.*
18	Tek boyut ölçülmüş, düzlem belirtilmemiş.	«Aksiyel düzlemde **[.. x .. mm]**, kraniokaudal **[.. mm]**.»	*Farklı düzlemde yapılan ölçüm takipte yanlış artış veya azalma izlenimi verir.*
19	Ölçüde birim yok: «Nodül 8.»	«Nodül **[.. mm]**.»	*Birimsiz sayı yanlış okunabilir ve tıbbi-hukuki açıdan savunulamaz.*
20	Karaciğer lezyonunda «sağ lobda».	«Segment **[..]**'de».	*Segment bilgisi cerrahi ve girişimsel planlama için standarttır.*
21	Kosta kırığında numara yok.	«Sağ **[..]**. kosta lateral arkta kırık.»	*Hangi kostanın kırık olduğu takip ve klinik muayene ile eşleştirme için gereklidir.*

GRUP 4

Bulgular

9 hata · Yazılan → Doğrusu → Neden

NO	YAZILAN	DOĞRUSU	NEDEN
22	İlk bulguda durulmuş; ikinci bulgu atlanmış.	Her bölge her seferinde aynı sırayla taranır; ikinci bulgu da yazılır.	*«Bulgu bulununca durmak» (satisfaction of search) en sık atlama nedenidir.*
23	Önemli negatif yazılmamış (apandisit sorusunda apendiksten söz yok).	«Apendiks doğal görünümde; akut apandisit lehine bulgu saptanmadı.»	*Klinik sorunun konusu olan organ yazılmazsa klinisyen değerlendirilip değerlendirilmediğini bilemez.*
24	Kanama sorusunda kemik penceresinden söz edilmemiş.	«Kemik penceresinde kalvaryumda kırık izlenmedi.»	*Travma BT'sinde kırık değerlendirmesi kemik penceresi gerektirir; yazılmazsa bakılmadığı varsayılır.*
25	Bulgular yorumla karışmış: «Pnömoni izlendi.»	Bulgular'da: «Hava bronkogramı içeren konsolidasyon.» Sonuç'ta: «Pnömoni ile uyumlu olabilir.»	*Bulgular gözlemi, Sonuç yorumu içerir; ikisi karışınca rapor savunulması zor hâle gelir.*
26	Tüp ve kateterlerden söz edilmemiş.	«ETT ucu karinanın **[.. cm]** üzerinde; SVK ucu superior vena kava projeksiyonunda.»	*Yoğun bakım grafilerinin en sık klinik sorusu cihaz konumudur.*
27	Görüntü alanındaki diğer yapılar atlanmış (toraks BT'de üst abdomen).	«Görüntülenen üst abdomen kesitlerinde **[patoloji izlenmedi/..]**.»	*Görüntü alanındaki her yapı raporlayanın sorumluluğundadır; adrenal veya karaciğer lezyonları sık kaçırılır.*
28	Aynı bulgu Bulgular'da üç kez tekrar edilmiş.	Her bulgu bir kez, ilgili organın altında yazılır.	*Tekrar raporu uzatır ve okuyanın asıl bulguyu bulmasını zorlaştırır.*
29	Kemik lezyonu tanımsız: «Kemikte lezyon.»	«**[Kemik]** te **[.. mm]**, **[litik/sklerotik]**, **[dar/geniş]** geçiş zonlu lezyon; periost reaksiyonu **[yok/var]**.»	*Kemik lezyonunun karakteri (geçiş zonu, matriks, periost) ayırıcı tanıyı belirler.*
30	Sıvı koleksiyonu için içerik ve ölçü verilmemiş.	«**[.. x .. mm]**, periferik kontrastlanan, içinde hava **[yok/var]** koleksiyon.»	*Drenaj kararı boyut, içerik ve duvar özelliklerine göre verilir.*

GRUP 5

Sonuç

8 hata · Yazılan → Doğrusu → Neden

NO	YAZILAN	DOĞRUSU	NEDEN
31	Sonuç, Bulgular'ın kopyası.	Sonuç'ta yalnızca anlamlı bulgular ve yorumu, önem sırasıyla.	*Sonuç bölümü bulguların özeti ve yorumudur; kopya yorum yapılmadığını gösterir.*
32	Sonuç klinik soruya yanıt vermiyor.	İlk cümle klinik soruyu yanıtlar: «Akut apandisit lehine bulgu saptanmadı.»	*İstemi yazan hekim ilk cümlede sorusunun yanıtını arar.*
33	İnsidental bulgu ilk sırada, acil bulgu sonda.	Acil bulgu her zaman ilk sırada; insidental bulgular en sonda.	*Okuyan çoğu zaman yalnızca ilk satırı okur.*
34	«Klinik ile korelasyon önerilir» (her raporda, gerekçesiz).	Neyle ve neden korele edileceğini yazın: «Laboratuvar enfeksiyon belirteçleri ile korelasyon önerilir.»	*Gerekçesiz korelasyon önerisi bilgi taşımaz ve raporun güvenilirliğini azaltır.*
35	Uzun ve kaçamaklı ayırıcı tanı listesi.	En olası tanı önce, ardından en fazla iki üç gerçekçi ayırıcı tanı.	*On maddelik liste klinisyene yön vermez; olasılık sırası yön verir.*
36	«Malignite dışlanamaz» (gerekçesiz).	Malignite lehine veya aleyhine bulguları ve önerilen bir sonraki adımı yazın.	*Gerekçesiz «dışlanamaz» gereksiz kaygı ve tetkik zinciri yaratır.*
37	Kesinlik düzeyi belirsiz: «Pnömoni?»	«Pnömoni ile uyumlu» / «pnömoni lehine» / «pnömoni olabilir» — hangisi olduğunu seçin.	*Soru işareti rapor dili değildir; güven düzeyi standart ifadelerle verilir.*
38	Önceki tetkike göre değişim Sonuç'ta yok.	«Önceki tetkike göre **[.. lezyonda]** gerileme.»	*Takip tetkikinde klinik karar değişime göre verilir.*

GRUP 6

Öneri

4 hata · Yazılan → Doğrusu → Neden

NO	YAZILAN	DOĞRUSU	NEDEN
39	«İleri tetkik önerilir.»	«Karakterizasyon için kontrastlı beyin MR önerilir.»	*Hangi tetkik ve neden yazılmazsa öneri uygulanamaz.*
40	Her bulguya takip önerisi eklenmiş.	Yalnızca klinik karar değiştirecek bulgulara spesifik öneri.	*Gereksiz öneri gereksiz tetkik, maliyet ve hasta kaygısı demektir.*
41	Emin olunmayan takip aralığı yazılmış.	«Takip gerekliliği güncel kılavuza göre klinik ekiple birlikte belirlenmelidir.» — veya hocanıza sorun.	*Yanlış aralık hastaya zarar verebilir; sayıdan emin değilseniz yazmayın.*
42	Tedavi önerisi yazılmış: «Antibiyotik başlanmalıdır.»	«Pnömoni ile uyumlu olabilir.»	*Tedavi kararı klinik ekibe aittir; radyoloji raporu tanısal bilgi sunar.*

GRUP 7

Acil bulgu ve bildirim

4 hata · Yazılan → Doğrusu → Neden

NO	YAZILAN	DOĞRUSU	NEDEN
43	Acil bulgu raporda var, bildirim yapılmamış.	Telefonla bildirin ve raporda kaydedin: «Klinik ekibe **[saat]**'te bildirilmiştir.»	*Rapor okunana kadar geçen süre hasta için kritik olabilir.*
44	Bildirim yapılmış ama raporda yok.	«**[Saat]**'te **[birim]** nöbetçi hekimine telefonla bildirilmiştir.»	*Yazılmayan bildirim, tıbbi-hukuki açıdan yapılmamış sayılabilir.*
45	Bildirim kaydı «hekime söylendi».	Kime (unvan ve birim), saat kaçta, hangi yolla ve geri okuma yapıldığı.	*Belirsiz kayıt bildirimin doğrulanmasını imkânsız kılar.*
46	Acil bulgu Sonuç'un ortasında.	Acil bulgu Sonuç'un ilk cümlesi.	*Hızlı okuyan klinisyen ilk satırda durabilir.*

GRUP 8

Biçim ve imza öncesi

4 hata · Yazılan → Doğrusu → Neden

NO	YAZILAN	DOĞRUSU	NEDEN
47	Raporda köşeli parantez veya şablon metni kalmış.	İmzadan önce [ ] ve «...» işaretleri aranır ve silinir.	*Kalan şablon metni raporun okunmadan gönderildiğini gösterir.*
48	Hasta adı, tetkik tarihi veya istem uyumsuz.	Hasta kimliği, tarih ve tetkik türü raporla eşleştirilir.	*Yanlış hastaya ait rapor en ciddi raporlama hatalarındandır.*
49	Kısaltmalar açıklanmadan kullanılmış (yerleşik olmayanlar).	Yerleşik olmayan kısaltmayı ilk kullanımda açık yazın.	*Rapor yalnızca radyologlar için değil, tüm klinisyenler için yazılır.*
50	Dikte veya yazım hatası: «sağ» yerine «sol», «hipo» yerine «hiper».	İmzadan önce raporu baştan sona bir kez okuyun.	*Tek harf hata bulgunun anlamını tersine çevirebilir.*

Eğitim amaçlıdır. Bu materyal asistanlık eğitiminin, gözetimin, klinik kararın veya uzman raporunun yerini almaz.

Sonraki adım

Şimdi Bonus 3 · Klinik Soruya Göre Rapor: 30 Klinik Soru'yu açın. Hataların önemli bir kısmı raporun klinik soruya yanıt vermemesinden doğar; en sık 30 soruda raporun mutlaka yanıtlaması gerekenleri görün.

Doğru cümle kalıpları için **Bonus 1 · 200 Sonuç Cümlesi Bankası**'na dönebilirsiniz.